TOSCANA DIAGNOSTICA

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

ISTRUZIONE DI LAVORO
TABELLA VALORI CRITICI (PANIC VALUES)

Area 18 – Laboratorio

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-IDL013_00	00	14/04/2026	3
Redatto da	**Approvato da**	**Classificazione**	**Stato**
Lab Ops / DS / RSGI	AD – Francesco Epifani	Interno	In vigore

Rif.: ISO 15189:2022 cl. 5.6 (comunicazione risultati critici) · TD-SGI-PRO040 (Comunicazione Paziente: panic values entro 60 min) · TD-SGI-IDL011 (Prelievo, Conservazione e Trasporto) · TD-SGI-IDL009 (Esami Particolari)

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Valentina Zezza	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
04/05/2026	04/05/2026	04/05/2026

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

1. Definizione e obbligo di comunicazione

I valori critici (panic values) sono risultati di laboratorio che rappresentano una condizione potenzialmente pericolosa per la vita del paziente e che richiedono una comunicazione immediata al medico curante o al medico di riferimento, affinché possano essere adottate tempestivamente le misure cliniche necessarie. La comunicazione dei valori critici al medico richiedente deve avvenire entro 60 minuti dalla validazione del risultato (rif. PRO040 Sez. 4.3). L'operatore che effettua la comunicazione registra nel sistema informatico di laboratorio (LIS): il valore critico rilevato, il nome del medico contattato, la data e l'ora della comunicazione, l'esito della comunicazione (medico raggiunto / non raggiunto con azioni intraprese).

2. Fonti

IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine); JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Health Organizations); RCP (Royal College of Pathologists); ASCP (American Society for Clinical Pathology); SIBIOC (Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica).

3. Tabella dei valori critici

ANALITA	LIVELLO CRITICO ADULTO	RACCOMANDAZIONE
CHIMICA CLINICA		
Calcio totale	< 6,6 mg/dL > 14 mg/dL	IFCC
Creatinina	> 7,5 mg/dL	IFCC
Bilirubina totale	> 14 mg/dL	IFCC
Glucosio	< 40 mg/dL > 350 mg/dL	JCAHO / IFCC
Sodio	< 120 mmol/L > 160 mmol/L	JCAHO / IFCC
Ammoniemia	> 154 µg/dL	IFCC
Potassio	< 2,8 mmol/L > 6,2 mmol/L	IFCC
Osmolalita	< 240 mOsmol/Kg > 330 mOsmol/Kg	IFCC
Calcio ione	< 0,7 mmol/L > 1,6 mmol/L	IFCC
Magnesio	< 1,0 mg/dL > 6,3 mg/dL	IFCC
Fosfato	< 1,0 mg/dL > 9,0 mg/dL	IFCC
pH	< 7,2 > 7,6	IFCC
PO2 (pressione parziale di ossigeno)	< 37 mmHg	IFCC
PCO2 (pressione parziale di anidride carbonica)	< 20 mmHg > 63 mmHg	ASCP
Troponina T hs (S-Troponina Ths)	> 400 pg/mL (oppure > 0,4 µg/L)	JCAHO / IFCC
COAGULAZIONE		
PT (paziente NON in TAO)	INR > 3,93	JCAHO
PT (paziente in TAO)	INR > 6,5	RCP
aPTT ratio	> 2,5	IFCC
Fibrinogeno	< 0,8 g/L	IFCC
EMATOLOGIA		
Leucociti	< 2.000/µL > 50.000/µL	IFCC
Neutrofili	< 500/µL	IFCC
Emoglobina	< 6,6 g/dL > 19,9 g/dL	IFCC
Piastrine	< 20.000/µL > 1.000.000/µL	IFCC

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

Esame morfologico striscio periferico	Presenza di emazie falciformi; presenza di parassita malarico	SIBIOC
FARMACI E TOSSICOLOGIA		
Fenitoina	> 25 mg/L	IFCC
Fenobarbitale	> 50 mg/dL	IFCC
Digossina	> 2,5 µg/L	JCAHO
Etanolo	> 3,5 g/L	IFCC
Carbamazepina	> 15 mg/L	IFCC
Acido valproico	> 150 mg/L	IFCC
Litio	> 1,5 mmol/L	JCAHO
URINE		
Glucosuria ed acetone	Elevata	SIBIOC
Emoglobinuria	Elevata in assenza di GR al microscopio	SIBIOC
Presenza di droghe di abuso	Positività	SIBIOC
INFETTIVOLOGIA		
HIV anticorpi e PCR	Positività	SIBIOC (procedura interna)
MICROBIOLOGIA		
Colturale feci	Rilevamento colturale Salmonella, Shigella, Campylobacter, C. difficile	SIBIOC
Emocoltura	Positività	IFCC

4. Procedura di comunicazione

Al rilevamento di un valore critico, l'operatore di laboratorio procede come segue: verifica il risultato (ripetizione del test sullo stesso campione o su aliquota, ove tecnicamente possibile); se il valore critico e confermato, comunica il risultato al medico richiedente o al medico di riferimento entro 60 minuti dalla validazione, per via telefonica o altro canale tracciabile; registra nel LIS il valore, il destinatario della comunicazione, la data, l'ora e l'esito; se il medico non e raggiungibile entro 60 minuti, l'operatore attiva il protocollo di escalation previsto dalla PRO040 (comunicazione al Direttore Sanitario o al medico di guardia della struttura richiedente).

5. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	14/04/2026	Prima emissione SGI	Francesco Epifani